

Fecha Última Actualización: 30-04-2022 10:59:29

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Jorge Antonio Soto Soto
Edad : 81a 10m 29d
Dirección : Diego Portales 265

Rut : 4.438.169-9
Fecha Nacto: 01/06/1940
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1023403
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9542 9528

N° Epicrisis
305451

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 14/04/2022 07:31
Fecha Egreso : 30/04/2022 10:04

Días Estadía: 16

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

PCR recuperado

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

JORGE SOTO SOTO
81 AÑOS
4438169-9
FI HSR 14/04/2022 07:16 horas
FI UPC 14/04/2022 14:00 horas
fALLECE: 10:35 hrs de 30/04/22

Antecedentes mórbidos: HTA, ICC CF III (FE 16%), Bypass femoral femoral izquierdo, anémico por úlcera gástrica, dislipidemia.

Medicamentos: Atorvastatina, carvedilol, Espironolactona, Losartánl, Aspirina

Alergias (-)

Hospitalizaciones previas: Junio 2021 SCA con SDST se traslada HLF (se desconoce manejo)

Historia clínica

Paciente es traído por familiares, sufre paro cardiorespiratorio a la entrada del hospital, es paro presenciado. Señala haber presentado dolor torácico y disnea al levantarse el día del ingreso en la mañana. Aunque posteriormente hija refiere que llevaba una semana con dolor precordial.

Ingresa a reanimación en PCR, se realizan maniobras de RCP avanzado, se intuba Crash tubo 8.0 a 21 cm al primer intento, sale a ritmo organizado al quinto ciclo.

ECG de ingreso en urgencias: IAM con SDST en pared anteroseptal, BAV 1er grado + BCRI, sin criterios de sgarbosa

Se solicita evaluación por UCO quienes activan hemodinamia de urgencia. En pabellón de angiografía se instala stent en ADA y diagonal, paciente ingresa a UPC con DVA a dosis altas: Noradrenalina 0.34 ug/k/m + Adrenalina 0.15 ug/k/m, sedación con midazolam + fentanyl todo por VVP, con línea arterial. Al ingreso a UPC evoluciona con bradicardia severa hasta 20 lpm, por lo que se instala MCP transitorio en VYID, sin incidentes. Se instala CVC femoral para administración de sedación y DVA.

Al examen físico de ingreso:

SAS 1, sedación midazolam + fentanyl

VMI VC: Vt 380, FR 20 rpm, PEEP 6, DP 12

Fecha Epicrisis : 30/04/2022 10:59

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 30-04-2022 10:59:29

Página 2 de 3

Extremidades frías, mala perfusión periférica
Cardíaco: Ritmo marcapasos a 80 lpm.
Pulmonar MP+ no ausculto ruidos agregados
EEII cicatriz de cirugía previa, frío con pulsos presentes y simétricos.

Ingres a UCI en malas condiciones:

1. Hemodinamia: Inestable, con sonda marcapaso transitorio + requerimiento alto de DVA (adrenalina + noradrenalina). Posterior a la instalación de Sonda MP paciente se estabiliza desde el punto de vista HDN, baja sus requerimientos de DVA hasta suspenderlos luego de 2 a 3 días. Permanece así hasta ahora.

2. Respiratorio: VMI protectora en contexto de PCR reciente. Buena compliance respiratorio. Se mantiene intubado para protección de vía aérea ya que nunca logra recuperar adecuada conciencia que permitiera su extubación. Evoluciona con CPAP hasta ahora. Nunca fue un gran problema en su evolución. En los últimos días se plantea TQT la que finalmente se decide no hacer por compromiso HDN las últimas 24 hrs.

3. Cardíaco: Requerimiento de instalación de sonda marcapasos dado bradicardia extrema, se deja FC 80 lpm. Posiblemente en contexto de evento isquémico no resuelto completamente. Se inicia doble antiagregación, atorvastatina dosis altas, Quedo Pendiente resolución en segundo tiempo de otros vasos comprometidos, la que no se pudo llevar a cabo porque paciente no mejoró en lo neurológico

4. Neurológico: Paciente ingresa en Glasgow bajo 7 que se mantiene estacionario y sin mejoría a pesar de que luego de unos días, cuando estuvo mejor en lo HDN se suspendiera la sedación. Se evalúa inicialmente con TAC sde cerebro y con RNM que no muestran graves lesiones, se asume como una encefalopatía hipóxico isquémica que luego da indicios de mal pronóstico al presentar mioclonías generalizadas. Dado es e contexto se evalúa en conjunto con neurología y se asume un mal pronóstico. Se conversa con la familia y se les transmite que es muy probable que paciente no logre conciencia. Ante eso se decide mantener manejo proporcional.

5. Renal: Evoluciona sin mayores cambios.

Hoy a las 10:35 hrs AM se constata su fallecimiento en presencia de familiares.

Diagnóstico de Egreso

- Shock cardiogénico - 1. Falla orgánica múltiple
- 2. Encefalopatía hipóxico isquémica
- 3. Paro cardiorespiratorio recuperado

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 30/04/2022 10:59

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:56

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 30-04-2022 10:59:29

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Andres Aquevedo Salazar
Médico Tratante (Staff)